

DRESS — reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos

(Basado en: Guías Clínicas MINSAL Chile 2023–2024, BAD 2023–2024, EADV 2023–2024, criterios RegiSCAR y J-SCAR, UpToDate 2025 y textos de dermatología clínica.)

1)

Introducción y relevancia clínica

El **DRESS** (también denominado **síndrome de hipersensibilidad a fármacos** o *DIHS* en la literatura japonesa) es una **reacción cutánea medicamentosa grave (SCAR)** caracterizada por **exantema**, **fiebre**, **eosinofilia/linfocitos atípicos** y **compromiso de órganos internos** (principalmente **hígado**, **riñón** y **pulmón**). A diferencia de erupciones benignas, el DRESS:

- Posee **latencia larga** (típicamente **2–8 semanas** post inicio del fármaco).
- Se asocia a **mortalidad de 5–10%**, sobre todo por **hepatitis fulminante**.
- Puede dejar **secuela autoinmune tardía** (tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, anemia hemolítica, miocarditis eosinofílica, entre otras).

Relevancia en EUNACOM

- Distinguir DRESS de **exantema maculopapular simple** (benigno) y de **SJS/TEN** (necrolisis epidérmica).
 - Reconocer **fármacos de alto riesgo** (alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, sulfamidas, minociclina, vancomicina, dapsona).
 - Aplicar **criterios RegiSCAR**, solicitar **estudios básicos** y **suspender inmediatamente** el agente causal.
 - Indicar **corticoides sistémicos** y **derivar/hospitalizar** cuando corresponda.
-

2)

Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo inmunológico

El DRESS es una **hipersensibilidad retardada tipo IV** (subtipo IVb/IVc) mediada por **linfocitos T**. El fármaco (o su metabolito reactivo) actúa como **hapteno** presentado por moléculas **HLA** específicas, activando linfocitos **CD4+ y CD8+** que liberan citocinas (**IL-5** pro-eosinofílica, **IFN- γ** , **TNF- α**). El resultado es:

- **Eosinofilia periférica y infiltración tisular.**
- **Lesión tisular** (hepatitis, nefritis intersticial, neumonitis, miocarditis).
- **Linfocitos atípicos** (activación policlonal).

2.2. Reactivación viral (teoría del “doble golpe”)

Existe evidencia consistente de **reactivación de herpesvirus** (sobre todo **HHV-6**, y en menor medida **EBV/CMV**). Esta reactivación secundaria podría:

- Potenciar la respuesta inmune y **agrarar el daño orgánico**.
- Explicar **recaídas** al reducir o suspender precozmente corticoides.
- Relacionarse con **secuela autoinmune tardía**.

2.3. Factores genéticos

Asociación con haplotipos HLA que **aumentan el riesgo** para fármacos específicos:

- **HLA-B*58:01** ↔ **alopurinol** (alto riesgo; prevalente en poblaciones asiáticas y presente en Latinoamérica).
- **HLA-B*15:02** ↔ **carbamazepina** (sobre todo SJS/TEN en asiáticos; relevancia variable en otros orígenes).
- Polimorfismos en **enzimas metabolizadoras** (epóxido hidrolasa, NAT, CYP) que favorecen metabolitos reactivos.

2.4. Fármacos implicados (alta sospecha)

- **Alopurinol** (el más asociado a hepatitis fulminante).
- **Anticonvulsivantes aromáticos:** **carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina.**

- **Sulfamidas** (cotrimoxazol), **dapsona**.
 - **Antibióticos**: minociclina, vancomicina.
 - Otros: **abacavir**, **nevirapina**, **omeprazol** (raro), **INH**.
-

3)

Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Cronología característica

- **Inicio tardío**: **2–8 semanas** tras comenzar el fármaco (clave para diferenciar de exantema simple).
- **Recaídas**: pueden ocurrir al **bajar corticoides** o con **infecciones intercurrentes**.

3.2. Manifestaciones cutáneas

- **Exantema morbiliforme/maculopapular difuso**, confluyente, **edematoso** y **pruriginoso**, que inicia en tronco y se extiende a extremidades.
- **Edema facial** marcado (sello semiológico frecuente).
- **Descamación fina** tardía; **pústulas** o **lesiones purpúricas** pueden aparecer.
- **Compromiso de mucosas** es **menos prominente** que en SJS/TEN (si está presente suele ser leve).

3.3. Síntomas sistémicos

- **Fiebre** >38–38,5 °C.
- **Linfadenopatías** generalizadas dolorosas.
- **Malestar**, **artralgias**.

3.4. Compromiso de órganos (variable)

- **Hígado** (60–90%): **hepatitis** con aumento de **ALT/AST**, a veces ictericia; riesgo de **hepatitis fulminante**.
- **Riñón** (10–30%): **nefritis intersticial** → ↑ creatinina, piuria estéril.
- **Pulmón**: **neumonitis intersticial**, tos/disnea, hipoxemia.
- **Corazón**: **miocarditis**/miopericarditis (rara pero grave).
- **Hematológico**: eosinofilia, linfocitos atípicos; rara vez agranulocitosis.
- **Tiroides** (tardío, semanas-meses): tiroiditis autoinmune (hipo/hipertiroidismo).
- Otros: páncreas (pancreatitis), SNC (meningoencefalitis), colon (colitis).

3.5. Diagnóstico diferencial (puntos finos)

Entidad	Claves que la distinguen
Exantema maculopapular simple	Latencia corta (5–10 días), sin fiebre alta, sin eosinofilia ni daño de órganos; evoluciona en 7–14 días tras suspender fármaco.
SJS/TEN	Ampollas/erosiones, necrosis epidérmica , mucosas severamente afectadas , Nikolsky (+); dolor cutáneo prominente.
AGEP (pustulosis exantemática aguda generalizada)	Pústulas estériles con neutrofilia, latencia breve (1–5 días), fiebre, descamación rápida.
EBV/CMV agudo	Faringitis, adenopatías, linfocitos atípicos, pero sin eosinofilia típica ni exposición farmacológica clara.
Síndromes linfoproliferativos	Adenopatías, citopenias; biopsia y serologías orientan.

4)

Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio inicial (todo paciente con sospecha)

- **Hemograma:** eosinofilia ($>700/\mu\text{L}$ o $>10\%$), **linfocitos atípicos**; puede haber leucocitosis o, menos frecuente, citopenias.
- **Perfil hepático:** ALT/AST, FA, GGT, **bilirrubina**.
- **Función renal:** creatinina, **BUN**; **orina completa** (piuria estéril, hematuria).
- **Proteína C reactiva, VSG.**
- **Electrolitos, albumina.**
- Si síntomas respiratorios: **gases, Rx/TC de tórax.**
- Si síntomas cardíacos: **ECG, troponina, ecocardiograma.**
- **Serologías/ PCR** para **HHV-6/EBV/CMV** (opcionales; útiles en casos severos o refractarios).
- **Autoinmunidad tardía** (TSH, anti-TPO) en seguimiento.

4.2. Biopsia de piel (apoya pero no es obligatoria)

- **Dermatitis de interfase** con exocitosis linfocitaria y **eosinófilos**; **espongiosis** variable; vasculitis leve ocasional.

4.3.

Criterios RegiSCAR

(clasificación)

Puntúan **sospecha/posible/probable/definitivo** según la suma de hallazgos:

- Fiebre $\geq 38.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Linfadenopatías ≥ 2 sitios.

- Eosinofilia ($\geq 700/\mu\text{L}$ o $\geq 10\%$; más puntos si $\geq 1.500/\mu\text{L}$ o $\geq 20\%$).
- Linfocitos atípicos.
- Afectación cutánea extensa (exantema $\geq 50\%$ SC, edema facial, infiltración).
- **Compromiso de órgano interno** (hígado, riñón, pulmón, corazón, etc.).
- Latencia típica (2–6 semanas) y curso prolongado.
- Exclusión de otras causas (cultivos/serologías).

Diagnóstico de trabajo: DRESS probable/definitivo por RegiSCAR + sospecha farmacológica.

5)

Tratamiento (según guías MINSAL / BAD / EADV)

5.1. Principios

1. **Suspender inmediatamente** el fármaco sospechoso y **evitar moléculas de la misma familia** (p. ej. todos los aromáticos si la reacción fue a carbamazepina/fenitoína).
2. **Evaluar gravedad y órganos afectados** (hígado, riñón, pulmón, corazón).
3. **Hospitalizar** si hay **fiebre alta, marcada alteración de laboratorio o compromiso de órgano**.
4. Manejo conjunto **Dermatología + Medicina Interna** (y **UCI** si se compromete la función orgánica).

5.2. Soporte general

- **Medidas sintomáticas:** antihistamínicos para prurito, emolientes, corticoides tópicos potentes en máculas/pápulas muy pruriginosas.
- **Hidratación** y manejo del estado nutricional.
- **Evitar AINES** (potenciales gatilladores) y nuevos fármacos innecesarios.

- **Profilaxis ocular** solo si síntomas (no como en SJS/TEN).

5.3.

Corticoides sistémicos

(piedra angular en formas moderadas–severas)

- **Prednisona 0,5–1 mg/kg/día** (o metilprednisolona IV 0,5–1 mg/kg/día si hospitalizado).
- En **hepatitis significativa** (ALT >5–10× LSN), **nefritis**, **neumonitis** o fiebre persistente → **iniciar corticoide sistémico**.
- **Pulsos** de metilprednisolona (250–500 mg/día x 3 días) podrían considerarse en deterioro orgánico rápido.
- **Descenso lento y prolongado** (al menos **6–8 semanas**, a veces 10–12) para prevenir **rebote/recidiva**.
 - Señal de rebote: reaparece exantema/fiebre/eosinofilia al bajar <0,2–0,3 mg/kg.

5.4.

Terapias de segunda línea / refractarios

- **Ciclosporina** 3–5 mg/kg/día (respuesta rápida; útil si corticodependencia o contraindicación a esteroides).
- **IVIG** 2 g/kg en 3–5 días (controvertida; considerar si compromiso severo multiorgánico o sospecha de reactivación viral significativa).
- **Micofenolato mofetilo**, **metotrexato** o **azatioprina**: casos excepcionales refractarios.
- **Antivirales** (*ganciclovir/valganciclovir*) **no** son de uso rutinario; podrían considerarse en **reactivación HHV-6/CMV documentada** con compromiso grave, en unidad especializada.

5.5. Manejo de situaciones específicas

- **Hepatitis severa:** control estricto de **INR, bilirrubina, encefalopatía**; coordinar con **hepatología** (riesgo de trasplante hepático en fulminante).
- **Nefritis intersticial:** hidratación, retirar nefrotóxicos, **corticoides** si deterioro progresivo.
- **Neumonitis:** oxigenoterapia, exclusión de infección bacteriana/viral; **corticoides**.
- **Miocarditis:** UCI, troponina seriada, ecocardiograma, **corticoides** + inmunosupresor si necesario.

5.6. Educación y prevención

- Registrar **fármaco causal** en ficha y **tarjeta de alergia**.
 - **Evitar reexposición** de por vida.
 - En antecedentes de alopurinol + DRESS, considerar **genotipificación HLA-B*58:01** en familiares de alto riesgo (evidencia más sólida en asiáticos).
-

6)

Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones agudas

- **Hepatitis fulminante** (principal causa de muerte).
- **Insuficiencia renal aguda** (nefritis intersticial).
- **Neumonitis / SDRA, miocarditis**.
- **Sepsis** por catéter/portales cutáneos (menos frecuente que en SJS/TEN).

6.2. Secuelas y complicaciones tardías (semanas–meses)

- **Enfermedades autoinmunes:**
 - **Tiroiditis autoinmune** (hipo/hipertiroidismo).

- **Diabetes tipo 1.**
- **Anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica.**
- **Miocarditis eosinofílica, síndrome seco.**
- **Hepatitis crónica** o colestasis prolongada.
- **Insuficiencia renal crónica** (raro).

6.3. Pronóstico

- Mortalidad global **5–10%** (↑ con hepatitis severa, edad avanzada, retraso en suspensión del fármaco).
- La mayoría **mejora** con suspensión del fármaco + **corticoides** bien pautados.
- Riesgo de **recaídas** si el **taper** es rápido o hay infección intercurrente.

7)

Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas clínicas

1. **Latencia larga (2–8 semanas)** tras iniciar el fármaco + **fiebre** + **exantema difuso** + **eosinofilia/linfocitos atípicos** = **piense en DRESS**.
2. **Edema facial** es un **hallazgo semiológico clave**.
3. **Hígado** es el órgano más afectado; **controle transaminasas seriadas**.
4. **Suspender de inmediato** el fármaco sospechoso y **no “esperar a ver”**.
5. **Corticoides sistémicos** (0,5–1 mg/kg/d) son **tratamiento de elección** si hay compromiso orgánico.
6. **Descenso lento** por **≥6–8 semanas** para evitar rebote.
7. Diferencie de **SJS/TEN**: en DRESS, **mucosas poco afectadas** y **no hay necrosis epidérmica extensa**.

□ Errores comunes

- **Confundir** DRESS con exantema simple y **no pedir labs** (eosinofilia, PFH, función renal).
 - **Mantener** el fármaco “porque el exantema es leve”.
 - Iniciar/retirar **corticoides** de forma **brusca** → **recidivas**.
 - **No monitorizar** hígado/riñón/pulmón/tiroides durante el curso y seguimiento.
 - **Reexponer** inadvertidamente al mismo fármaco o a **familia química relacionada**.
 - Pasar por alto **linfadenopatías** y **edema facial** como “datos menores”.
-

8)

Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **DRESS** es una **reacción medicamentosa grave** con **latencia de 2–8 semanas**, **exantema difuso**, **fiebre**, **eosinofilia/linfocitos atípicos** y **compromiso de órganos** (hígado, riñón, pulmón, corazón).
2. Fármacos clásicos: **alopurinol**, **carbamazepina/fenitoína/fenobarbital/lamotrigina**, **sulfamidas**, **minociclina**, **vancomicina**, **dapsona**.
3. **Criterios RegiSCAR** permiten clasificar la probabilidad diagnóstica; solicite **hemograma**, **PFH**, **función renal**, **orina**, **Rx/TC** según clínica.
4. **Primer paso: suspender el fármaco causal** y **hospitalizar** si hay compromiso sistémico.
5. **Corticoides sistémicos** (prednisona 0,5–1 mg/kg/d) son el **pilar terapéutico** en casos moderados–severos; **taper lento (≥6–8 semanas)**.
6. Alternativas en refractarios: **ciclosporina**; considerar **IVIG** seleccionadamente.
7. Controlar **secuela autoinmune tardía** (TSH, glucemia, síntomas cardíacos) por **meses**.